DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: HUGO DOMINGUEZ ANGARITA **Identificación** CC 16358576
Edad: 64 AÑOS **Empresa:** EPS SURA SUBSIDIADO-2025
Sala: QUIROFANO 3 **Fecha programación de cirugía:** 07/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	**043103**	**NEURORRAFIA DE NERVIO EN BRAZO**	Y44	

Cirujano: FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA **Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Vía: BRAZO DERECHO

1	**770201**	**SECUESTRECTOMIA, DRENAJE, DESBRIDAMIENTO DE HUMERO**	Y39	

Cirujano: FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA **Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Vía: BRAZO DERECHO

1	**780201**	**INJERTO OSEO EN HUMERO**	Y41	

Cirujano: FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA **Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Vía: BRAZO DERECHO

1	**793210**	**REDUCCION ABIERTA DE FRACTURA EN DIAFISIS DE HUMERO CON FIJACION INTERNA (DISPOSITIVOS DE FIJACION U OSTEOSINTESIS)**	Y42	

Cirujano: FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA **Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Vía:

1	**807101**	**SINOVECTOMIA DE HOMBRO PARCIAL VIA ABIERTA**	Y36	

Cirujano: FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA **Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Vía: BRAZO DERECHO

1	**817204**	**LIGAMENTORRAFIA O REINSERCION DE LIGAMENTOS VIA ABIERTA**	Y41	

Cirujano: FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA **Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Vía: BRAZO DERECHO

1	**834202**	**TENOSINOVECTOMIA**	Y37	

Cirujano: FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA **Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Vía: BRAZO DERECHO

1	**836301**	**REPARACION DEL MANGUITO ROTADOR VIA ABIERTA**	Y43	

Cirujano: FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA **Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Vía: BRAZO DERECHO

1	**837601**	**TRANSFERENCIAS MIOTENDINOSAS DE HOMBRO**	Y39	

Cirujano: FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA **Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Vía: BRAZO DERECHO

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES169 FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA **Especialidad** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

043103 **NEURORRAFIA DE NERVIO EN BRAZO**
770201 **SECUESTRECTOMIA, DRENAJE, DESBRIDAMIENTO DE HUMERO**
780201 **INJERTO OSEO EN HUMERO**
793210 **REDUCCION ABIERTA DE FRACTURA EN DIAFISIS DE HUMERO CON FIJACION INTERNA (DISPOSITIVOS DE FIJACION U OSTEOSINTESIS)**
807101 **SINOVECTOMIA DE HOMBRO PARCIAL VIA ABIERTA**
817204 **LIGAMENTORRAFIA O REINSERCION DE LIGAMENTOS VIA ABIERTA**
834202 **TENOSINOVECTOMIA**
836301 **REPARACION DEL MANGUITO ROTADOR VIA ABIERTA**
837601 **TRANSFERENCIAS MIOTENDINOSAS DE HOMBRO**

Dx Preoperatorio: S423 FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL HUMERO

Dx Postoperatorio: S423 FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL HUMERO

Tipo de Herida: LIMPIA **Tipo de Anestesia:** BLOQUEO NERVIO **Tipo de Cirugía:** URGENCIAS
Cantidad de Sangrado: 120 **ml.** **Vía:** UNICA VIA

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0

Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 07/11/26 **Fecha Final** 07/11/26
Hora Inicio 11:30:00 **Hora Final** 13:00:00

Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:

DECUBITO SUIINO - ASEPSIA + ANTISEPSIA CON CLORHEXIDINA EN MSD-CAMPOS ESTERILES.
EXISTE FRACTURA CONMINUTA DIAFISARIA DE HUMERO DERECHO X PAF SE REALIZA INCISIÓN DE 1200 MM EN REGION ANTEROLATERAL DEL BRAZO DERECHO - DISECCIÓN POR PLANOS HASTA EL FOCO DE FRACTURA DIAFISIARIA DE HUMERO -SE OBSERVA GRAN CONMINUCIÓN OSEA -SE REALIZA SECUESTRECTOMIA + DRENAJE Y DESBRIDAMIENTO PERISIOTICO EN HUMERO REMOVIENDO REACCIÓN PERIÓSTICA INFLAMATORIA PARA FAVORECER EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE LA FRACTURA.
SE REALIZAN MANIOBRAS DE REDUCCIÓN ABIERTA FRACTURA DE HUMERO Y FIJACIÓN INTERNA CON :
- 1 PLACA DE COMPRESIÓN Y BLOQUEO ESTRECHA DE 4,5 / 5,0 MM X 12 ORIFICIOS
- 3 TORNILLOS CORTICALES DE 4,5 X 26 MM
- 4 TORNILLOS DE BLOQUEO DE 5,0 MM (1 X 20 1 X 26 + 2 X 30 MM)
SE VISUALIZA EN EL INTENSIFICADOR DE IMÁGENES ADECUADA REDUCCIÓN, OSTEOSÍNTESIS ESTABLE Y TORNILLOS BIEN POSICIONADOS.
SE REALIZA APLICACIÓN DE INJERTO OSEO AUTÓLOGO TOMADO CON CURETA A TRAVÉS DE " VENTANA " OSEA EN CORTICAL LATERAL SANA DE METAFISIS PROXIMAL DE HUMERO IPSILATERAL , SE OBTIENE 2 CC DE HUESOS ESPONJOSO - SE APLICA SOBRE EL DEFECTO DE LA CONMINUCIÓN
SE OBSERVA ATRAPAMIENTO TRAUMÁTICO DEL NERVIO MEDIANO A NIVEL DEL FOCO DE FRACTURA, CON SIGNOS DE HIPOPERFUSIÓN Y PALIDEZ ASOCIADA – SE REALIZA DESCOMPRESIÓN DE NERVIO EN BRAZO (N. MEDIANO) LOGRANDO ADECUADA LIBERACIÓN Y RESTABLECIENDO LENTAMENTE SU PERFUSIÓN.
SE PERCIBE INESTABILIDAD TRAUMÁTICA EN HOMBRO IPSILATERAL . SE EXTIENDE HERIDA PROXIMALMENTE HACIA EL HOMBRO DERECHO - DISECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE ESTRUCTURAS LIGAMENTARIAS- EXISTE RUPTURA TRAUMÁTICA COMPLETA DEL LIGAMENTO GLENOHUMERAL ANTEROLATERAL EN SUS FIBRAS SUPERFICIALES E INTERMEDIAS CON INESTABILIDAD ARTICULAR SECUNDARIA- SE REALIZA DISECCIÓN DE FIBRAS, REGULARIZACIÓN DE EXTREMOS Y LIGAMENTORRAFIA A LATERAL EN HOMBRO LOGRANDO RESTABLECER ESTABILIDAD ARTICULAR DEL HOMBRO.

EXISTE GRAN SINOVITIS POSTRAUMATICA CON LIMITACION FUNCIONAL SECUNDARIA- SE REALIZA SINOVECTOMIA TOTAL DEL HOMBRO DERECHO POR VIA ABIERTA REMOVIENDO TEJIDO SINOVIAL PROLIFERATIVO Y RESTABLECIENDO ADECUADA FUNCIONALIDAD .
EXPLORACION DE ESTRUCTURAS ANATOMICAS - EXISTE AVULSION TRAUMÁTICA DEL 80 % DEL TENDON CORTO DEL BICEPS BRAQUIAL EN SUS FIBRAS SUPERFICIALES E INTERMEDIAS. SE DISECAN FIBRAS, SE REGULARIZAN EXTREMOS, SE LE DA AVANCE E INTENTO DE TENORRAFIA TERMINOTERMINAL QUEDANDO A " TENSION " Y CON RIESGO DE DESGARRO POR LO CUAL SE REALIZA REFORZAMIENTO DEL MISMO MEDIANTE TRANSFERENCIA TENDINOSA DEL TENDON LARGO DEL BÍCEPS IPSILATERAL - SE SUTURA CON PROLENE SE LOGRA REESTABLECER ANATOMIA ADECUADAMENTE.
EXISTE DESGARRO TRAUMÁTICO DEL NERVIO RADIAL DERECHO– SE REALIZA DISECCIÓN DEL MISMO LOGRANDO DESCENDER EL SEGMENTO PROXIMAL RETRAÍDO - REGULARIZACIÓN DE EXTREMOS - SE REALIZA NEURORRAFIA EN BRAZO (NERVIO RADIAL) CON TÉCNICA TERMINOTERMINAL LOGRANDO RESTABLECER ADECUADAMENTE SU ANATOMÍA.
LAVADO CON SSN – CURATIVO CON APÓSITO Y VENDAJE.

Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Hallazgos :

-FRACTURA CONMINUTA DIAFISARIA DE HUMERO DERECHO X PAF
-ATRAPAMIENTO TRAUMÁTICO DEL NERVIO MEDIANO A NIVEL DEL FOCO DE FRACTURA, CON SIGNOS DE HIPOPERFUSIÓN Y PALIDEZ ASOCIADA.
-. RUPTURA TRAUMÁTICA COMPLETA DEL LIGAMENTO GLENOHUMERAL ANTEROLATERAL EN SUS FIBRAS SUPERFICIALES E INTERMEDIAS CON INESTABILIDAD ARTICULAR SECUNDARIA-
-GRAN SINOVITIS POSTRAUMATICA CON LIMITACION FUNCIONAL SECUNDARIA.
-DESGARRO TRAUMÁTICO DEL NERVIO RADIAL DERECHO.
-AVULSION TRAUMÁTICA DEL 80 % DEL TENDON CORTO DEL BICEPS BRAQUIAL EN SUS FIBRAS SUPERFICIALES E INTERMEDIAS.

Tejidos enviados a patología : **SI** ☐ **NO** ☒

OTROS PARTICIPANTES

CÓDIGO	NOMBRE	TIPO
ES169	FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA	ESPECIALISTA

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

ES186	MARIO GERMAN OROZCO SANDOVAL	ANESTESIOLOGO
MG303	PAULA ANDREA RODRIGUEZ RIOS	AYUDANTE

FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA
Reg. 76-9390/95
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

***** FIN DEL REPORTE *****